FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
FIOCRUZ BRASÍLIA
COLABORATÓRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SOCIEDADE (CTIS)

WAGNER DE JESUS MARTINS
FERNANDA MACHINER
MARIA EDUARDA SILVA
JEFERSON MARTINS DE CASTRO

DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE, VIGILÂNCIA POPULAR E GOVERNANÇA PARTICIPATIVA TERRITORIAL:

estudo de caso de métodos mistos da implementação da metodologia PICAPS no Sol Nascente/Pôr do Sol, Distrito Federal



BRASÍLIA
2026

PICAPS
FIOCRUZ | Brasília
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE

WAGNER DE JESUS MARTINS
FERNANDA MACHINER
MARIA EDUARDA SILVA
JEFERSON MARTINS DE CASTRO

DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE, VIGILÂNCIA POPULAR E GOVERNANÇA PARTICIPATIVA TERRITORIAL:

estudo de caso de métodos mistos da implementação da metodologia PICAPS no Sol Nascente/Pôr do Sol, Distrito Federal

Projeto de pesquisa apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Fiocruz Brasília, por meio da Plataforma Brasil, e a [agência ou edital de financiamento], desenvolvido pelo CoLaboratório de Ciência, Tecnologia, Inovação e Sociedade (CTIS) da Fiocruz Brasília em parceria com a Universidade de Brasília e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

Equipe: [nomes, instituições e funções; links do Currículo Lattes].

BRASÍLIA
2026

RESUMO

Metodologias participativas de vigilância em saúde são promovidas para aproximar o conhecimento produzido nos territórios das respostas dos serviços, mas pouco se sabe sobre o que acontece com esse conhecimento depois de registrado, nem se os problemas que se tornam visíveis correspondem às condições que mais afetam a saúde da população. Este projeto analisa como, para quem e em que condições a metodologia de governança participativa territorial da Plataforma de Inteligência Cooperativa com a Atenção Primária à Saúde (PICAPS) transforma conhecimentos produzidos no território em deliberação coletiva e em respostas dos serviços de Atenção Primária à Saúde e de Vigilância em Saúde, articulando essa análise ao dimensionamento dos determinantes sociais da saúde. Trata-se de estudo de caso de métodos mistos com predominância qualitativa, no Sol Nascente/Pôr do Sol, Distrito Federal. O componente qualitativo é longitudinal, tem os quatro setores do território como unidades incorporadas e é conduzido como avaliação de processo informada pela abordagem realista: em três ondas, serão realizadas cerca de 100 entrevistas com 44 participantes, observação de reuniões e oficinas, análise documental, rastreamento de 24 trajetórias de alertas e demandas e oito oficinas de interpretação. O componente quantitativo é um inquérito domiciliar transversal, em amostra probabilística por conglomerados de cerca de 840 domicílios, com questionário misto baseado no referencial da Organização Mundial da Saúde, que reúne itens de inquéritos oficiais e escalas validadas no Brasil, como a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, e seis questões abertas. A integração ocorrerá pela seleção de participantes, pela devolução dos resultados às redes ativadas e por joint displays por setor. Espera-se produzir o perfil dos determinantes por setor, uma teoria do programa sustentada empiricamente, uma tipologia das trajetórias entre comunidade e serviços e recomendações para a articulação entre Salas de Cooperação Social e serviços de saúde.

Palavras-chave: determinantes sociais da saúde; vigilância popular em saúde; participação social; Atenção Primária à Saúde; métodos mistos.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Teoria inicial do programa: configurações contexto–mecanismo–resultado..... 15
Quadro 2 – Participantes, critérios de inclusão e estimativas de entrevistas..... 18
Quadro 3 – Ondas de produção de dados por setor (meses do projeto)..... 19
Quadro 4 – Dimensões do questionário, níveis do referencial e instrumentos de origem..... 21
Quadro 5 – Estratégias de integração entre o inquérito e o componente qualitativo..... 23
Quadro 6 – Critérios de rigor e procedimentos correspondentes..... 24
Quadro 7 – Matriz de consistência do estudo..... 25
Quadro 8 – Cronograma de execução por semestre..... 30
Quadro 9 – Orçamento estimado..... 31

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABEP	Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa
ACS	Agente Comunitário de Saúde
APS	Atenção Primária à Saúde
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CNS	Conselho Nacional de Saúde
CTIS	CoLaboratório de Ciência, Tecnologia, Inovação e Sociedade
DPT	Diálogos Prospectivos Territoriais
EBIA	Escala Brasileira de Insegurança Alimentar
EDE	Escala de Discriminação Explícita
ELSA-Brasil	Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto
ESF	Estratégia Saúde da Família
Fiocruz	Fundação Oswaldo Cruz
HWISE	Household Water Insecurity Experiences
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEDF	Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal
IVT+A	Índice de Vulnerabilidade Territorial Ampliado
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MTEI	Matriz de Tradução Epistêmica Intercultural
OMS	Organização Mundial da Saúde
PDAD-A	Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada
PICAPS	Plataforma de Inteligência Cooperativa com a Atenção Primária à Saúde
PNS	Pesquisa Nacional de Saúde
SCS	Sala de Cooperação Social
SES-DF	Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
SUS	Sistema Único de Saúde
TIDieR	Template for Intervention Description and Replication
UBS	Unidade Básica de Saúde
UnB	Universidade de Brasília

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 8
2 JUSTIFICATIVA 10
3 PROBLEMA, QUESTÕES E PRESSUPOSTOS 11
3.1 PROBLEMA DE PESQUISA 11
3.2 OBJETO 11
3.3 PERGUNTA CENTRAL 11
3.4 QUESTÕES ESPECÍFICAS 11
3.5 PRESSUPOSTOS ORIENTADORES 12
4 OBJETIVOS 13
4.1 OBJETIVO GERAL 13
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13
5 REFERENCIAL TEÓRICO 14
5.1 DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE E TERRITÓRIO USADO 14
5.2 VIGILÂNCIA POPULAR, EDUCAÇÃO POPULAR E COPRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 14
5.3 REDES SOCIOTÉCNICAS, TRADUÇÃO E GOVERNANÇA PARTICIPATIVA 15
5.4 AVALIAÇÃO DE PROCESSO E ABORDAGEM REALISTA 15
6 METODOLOGIA 17
6.1 TIPO DE ESTUDO E DESENHO 17
6.2 A INTERVENÇÃO ESTUDADA 17
6.3 CENÁRIO, CASO E UNIDADES DE ANÁLISE 18
6.4 PARTICIPANTES E AMOSTRAGEM 18
6.5 ONDAS LONGITUDINAIS E PRODUÇÃO DE DADOS QUALITATIVOS 19
6.6 INQUÉRITO DOMICILIAR SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE 20
6.6.1 Desenho, população e amostra 20
6.6.2 Questionário 20
6.6.3 Adaptação, pré-teste e coleta 22
6.6.4 Análise do inquérito 22
6.7 INTEGRAÇÃO ENTRE OS COMPONENTES 23
6.8 ANÁLISE DOS DADOS QUALITATIVOS 23
6.9 RIGOR, REFLEXIVIDADE E INDEPENDÊNCIA ANALÍTICA 24
6.10 MATRIZ DE CONSISTÊNCIA 24
6.11 DADOS SECUNDÁRIOS DE CONTEXTO 25
7 ASPECTOS ÉTICOS 26
7.1 MARCO NORMATIVO E TRAMITAÇÃO 26
7.2 CONSENTIMENTO 26
7.3 RISCOS E BENEFÍCIOS 26
7.4 PROTEÇÃO DE DADOS 27
7.5 DEVOLUTIVA E GOVERNANÇA COMUNITÁRIA 27
8 LIMITAÇÕES 28
9 RESULTADOS ESPERADOS E PRODUTOS 29
10 CRONOGRAMA 30
11 RECURSOS E ORÇAMENTO 31
REFERÊNCIAS 32

APÊNDICE A – ROTEIRO-BASE DE ENTREVISTA COM PESQUISADORES POPULARES..... 36
APÊNDICE B – GUIA DE OBSERVAÇÃO DAS REUNIÕES DAS SALAS DE COOPERAÇÃO SOCIAL..... 37
APÊNDICE C – FICHA DE RASTREAMENTO DE TRAJETÓRIA..... 38
APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO MISTO SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE..... 39
ANEXO A – ESCALA BRASILEIRA DE INSEGURANÇA ALIMENTAR (EBIA)..... 46
ANEXO B – CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL 2026..... 48

1 INTRODUÇÃO

A saúde de uma população é produzida pelas condições materiais e pelas relações sociais que se inscrevem no território, e não se distribui ao acaso no espaço urbano (LAURELL, 1982; BREILH, 2006; BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). O Sistema Único de Saúde (SUS) incorporou essa concepção ampliada em seu marco constitucional e legal (BRASIL, 1988; 1990) e organizou a Atenção Primária à Saúde (APS) com base territorial. Ainda assim, os sistemas de informação e as rotinas dos serviços nem sempre reconhecem, com oportunidade e granularidade suficientes, os problemas que os moradores percebem no cotidiano, sobretudo nas periferias urbanas, onde a distância entre o território vivido e o território registrado tende a ser maior (PAIM, 2018).

A vigilância popular em saúde tem sido proposta como forma de aproximar essas duas realidades, ao reconhecer moradores e organizações comunitárias como produtores legítimos de conhecimento sobre o próprio território (MACHADO et al., 2024; OLIVEIRA et al., 2024). Sua contribuição, contudo, não pode ser presumida. Ela depende da qualidade dos registros, da segurança de quem observa, da disposição e da capacidade dos serviços de responder e das condições que permitem sustentar a participação ao longo do tempo. Experiências participativas também podem reproduzir assimetrias de voz, sobrecarregar lideranças e gerar expectativas que as instituições não atendem (TRAD; ESPERIDIÃO, 2009).

A Plataforma de Inteligência Cooperativa com a Atenção Primária à Saúde (PICAPS), desenvolvida pelo CoLaboratório de Ciência, Tecnologia, Inovação e Sociedade (CTIS) da Fiocruz Brasília em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), opera desde 2020 em territórios do Distrito Federal (MARTINS et al., 2024; SELLERA et al., 2019). Sua metodologia de governança participativa territorial organiza-se em seis etapas encadeadas: a ativação das redes sociotécnicas do território; o diagnóstico multidimensional e a cartografia social realizados com essa rede, segundo os Diálogos Prospectivos Territoriais (DPT); a elaboração do Plano Popular; a formação de pesquisadores populares entre os participantes da cartografia; e a instalação das Salas de Cooperação Social (SCS), nas quais esses pesquisadores atuam na vigilância popular em saúde e na defesa, promoção e articulação para a efetivação do Plano Popular (FIOCRUZ BRASÍLIA, 2026a; 2026b).

Este projeto propõe um estudo de caso de métodos mistos da implementação dessa metodologia no Sol Nascente/Pôr do Sol (Região Administrativa XXXII), durante o seu primeiro ciclo de implantação. Um componente qualitativo longitudinal acompanha a metodologia em ação; um inquérito domiciliar, com questionário que combina questões estruturadas e abertas, dimensiona os determinantes sociais da saúde nos quatro setores do território. O foco não é estimar o efeito da intervenção sobre indicadores de saúde, objetivo para o qual o desenho de um único território e o horizonte de 36 meses seriam insuficientes. O foco é compreender **como, para quem e em que condições** a metodologia transforma conhecimentos produzidos no território em deliberação coletiva e em respostas dos serviços de saúde, e se os problemas que ela torna visíveis correspondem às condições que mais pesam sobre a saúde dos moradores.

O documento está organizado em onze seções. Após esta introdução, apresentam-se a justificativa (seção 2), o problema, as questões e os pressupostos (seção 3), os objetivos (seção 4) e o referencial teórico, que culmina na teoria inicial do programa (seção 5). A seção 6 detalha a metodologia; a seção 7,

os aspectos éticos; a seção 8, as limitações; a seção 9, os resultados esperados; e as seções 10 e 11, o cronograma e os recursos.

2 JUSTIFICATIVA

A justificativa do estudo assenta-se em quatro argumentos: uma lacuna de conhecimento, uma necessidade avaliativa da própria intervenção, uma demanda de gestão e a ausência de dados domiciliares sobre os determinantes sociais da saúde no território.

O primeiro argumento é a **lacuna de conhecimento**. A literatura brasileira sobre vigilância popular descreve experiências e fundamenta o conceito (MACHADO et al., 2024; OLIVEIRA et al., 2024), mas são escassos os estudos que acompanham longitudinalmente o que acontece com a informação produzida pela comunidade depois que ela é registrada: por onde circula, como é traduzida para a linguagem dos serviços, quem a valida, quando produz resposta e quando se perde. Essa trajetória é justamente o elo do qual depende qualquer efeito sobre a saúde, e é o elo menos estudado.

O segundo argumento é **avaliativo**. O referencial do Medical Research Council para intervenções complexas recomenda que a estimação de efeitos seja precedida, ou acompanhada, por uma avaliação de processo capaz de descrever a implementação, os mecanismos e o contexto (MOORE et al., 2015; SKIVINGTON et al., 2021). Sem esse conhecimento, um eventual estudo de efeito não saberia o que está avaliando, nem por que a intervenção funciona ou falha. A PICAPS acumula seis anos de operação, mas sua teoria do programa ainda não foi explicitada nem confrontada sistematicamente com dados empíricos.

O terceiro argumento é a **demanda de gestão**. A SES-DF e as equipes de APS precisam saber em que condições os alertas e as demandas oriundos das Salas de Cooperação Social podem ser incorporados às rotinas sem sobrecarregar os serviços, e que arranjos institucionais tornam essa articulação sustentável. O estudo produzirá recomendações diretamente aplicáveis a esse problema.

O quarto argumento é a **ausência de dados domiciliares sobre determinantes sociais da saúde** no território. As fontes disponíveis, como a PDAD-A, produzem estimativas para a Região Administrativa como um todo e não permitem comparar os setores entre si nem descrever grupos internos ao território (IPEDF, 2023). Sem esse dimensionamento, não há como saber se os problemas priorizados nos processos participativos correspondem às condições mais prevalentes ou apenas às mais visíveis para quem participa. O inquérito proposto preenche essa lacuna e oferece às Salas de Cooperação Social uma base de comparação própria.

O Sol Nascente/Pôr do Sol foi escolhido por combinar alta vulnerabilidade e escala compatível com a implantação faseada da metodologia. Segundo o diagnóstico situacional elaborado pela PICAPS a partir da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada (PDAD-A 2024), o território tem cerca de 108,7 mil habitantes, a segunda menor renda domiciliar per capita do Distrito Federal (R$ 846) e a maior proporção de domicílios em ruas que alagam (66%) (FIOCRUZ BRASÍLIA, 2026c). Esses números serão conferidos nas fontes primárias antes da submissão, com ano, recorte territorial e método explicitados. Sua função aqui é apenas situar o caso, não fundamentar inferências.

3 PROBLEMA, QUESTÕES E PRESSUPOSTOS

3.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Não se sabe como, para quem e em que condições uma metodologia de governança participativa territorial consegue transformar conhecimentos produzidos pela comunidade em deliberação coletiva legítima e em respostas efetivas dos serviços de APS e de Vigilância em Saúde, nem quais mecanismos explicam os casos em que essa transformação ocorre e aqueles em que fracassa.

3.2 OBJETO

O objeto é o processo de implementação da metodologia de governança participativa territorial da PICAPS no Sol Nascente/Pôr do Sol, observado em seus quatro setores (Trechos 1, 2 e 3 e Pôr do Sol), da ativação das redes sociotécnicas à operação das Salas de Cooperação Social, com ênfase nas trajetórias que ligam o conhecimento comunitário à resposta institucional, e a distribuição dos determinantes sociais da saúde nesses setores, tomada como contexto e contraponto dos processos participativos.

3.3 PERGUNTA CENTRAL

Como, para quem e em que condições a metodologia de governança participativa territorial da PICAPS transforma conhecimentos produzidos no território em deliberação coletiva e em respostas dos serviços de saúde no Sol Nascente/Pôr do Sol?

3.4 QUESTÕES ESPECÍFICAS

A pergunta central desdobra-se em seis questões, cada uma correspondente a um objetivo específico (seção 4) e articulada a fontes e procedimentos analíticos na matriz de consistência (Quadro 7):

a) Q1 – como se distribuem os determinantes sociais da saúde entre os setores e os grupos sociais do território, e como os moradores percebem os problemas que afetam sua saúde;

b) Q2 – como as redes sociotécnicas são ativadas e quem delas participa, permanece, se afasta ou fica de fora do processo, inclusive da formação de pesquisadores populares;

c) Q3 – como problemas de saúde são identificados, registrados, validados e priorizados na cartografia social, no Plano Popular e na vigilância popular, e onde os saberes comunitários e institucionais convergem ou divergem;

d) Q4 – que trajetórias percorrem os alertas da vigilância popular e as demandas do Plano Popular até a resposta, a recusa ou a ausência de resposta dos serviços e da gestão, e o que explica essas diferenças;

e) Q5 – como as Salas de Cooperação Social se constituem como espaços de governança participativa, quem delibera, com que legitimidade e com que relações de poder, e como isso muda ao longo do tempo;

f) Q6 – em que contextos e por quais mecanismos a metodologia produz, ou deixa de produzir, os resultados esperados, e que efeitos não previstos ou adversos emergem.

3.5 PRESSUPOSTOS ORIENTADORES

Em lugar de hipóteses a testar, o estudo adota pressupostos sensibilizadores, que orientam a atenção do campo sem predeterminar os achados e serão ativamente confrontados com casos divergentes:

a) P1 – **pluralidade epistêmica**: registros comunitários e institucionais expressam formas distintas de observar, classificar e priorizar problemas, e nenhuma delas será tratada a priori como padrão de verdade (FUNTOWICZ; RAVETZ, 1993);

b) P2 – **tradução**: a informação comunitária só produz resposta quando é traduzida para categorias, canais e atribuições que os serviços reconhecem, e essa tradução depende de mediadores e de objetos-fronteira (CALLON, 1986; STAR; GRIESEMER, 1989);

c) P3 – **participação desigual**: espaços participativos podem ampliar vozes antes ausentes e, ao mesmo tempo, reproduzir assimetrias de representação e influência (TRAD; ESPERIDIÃO, 2009);

d) P4 – **contingência**: os resultados dependem do contexto, da continuidade das equipes, dos recursos e de acontecimentos externos, e incluem efeitos nulos, contraditórios e adversos, como demandas registradas que nunca recebem resposta;

e) P5 – **medida e narrativa**: o dimensionamento dos determinantes por inquérito e as prioridades construídas nos processos participativos são representações distintas do território; discordâncias entre elas, como um problema prevalente que não chega ao Plano Popular, são informação sobre quem é ouvido e sobre o que se torna visível, e não erro de uma das fontes.

4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

Analisar como, para quem e em que condições a metodologia de governança participativa territorial da PICAPS é implementada e transforma conhecimentos produzidos no território em deliberação coletiva e em respostas dos serviços de Atenção Primária à Saúde e de Vigilância em Saúde, no Sol Nascente/Pôr do Sol, Distrito Federal, ao longo de seu primeiro ciclo de implantação, articulando essa análise ao dimensionamento dos determinantes sociais da saúde nos setores do território.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) dimensionar os determinantes sociais da saúde nos quatro setores do território, por meio de inquérito domiciliar com questionário misto, descrevendo sua distribuição entre setores e grupos sociais e as percepções dos moradores sobre os problemas que afetam sua saúde (Q1);

b) analisar a ativação das redes sociotécnicas e a constituição do grupo de pesquisadores populares, identificando quem participa, permanece, se afasta ou fica de fora, e por quê (Q2);

c) compreender como problemas de saúde são identificados, registrados, validados e priorizados por atores comunitários e institucionais, examinando convergências e divergências entre seus saberes e confrontando as prioridades construídas com o dimensionamento dos determinantes (Q3);

d) reconstruir as trajetórias de alertas da vigilância popular e de demandas do Plano Popular até a resposta, a recusa ou a ausência de resposta, identificando as condições que explicam cada desfecho (Q4);

e) analisar a constituição e a transformação das Salas de Cooperação Social como espaços de governança participativa, considerando deliberação, legitimidade e relações de poder (Q5);

f) refinar a teoria do programa da metodologia, explicitando configurações de contexto, mecanismo e resultado que expliquem resultados esperados, não esperados e adversos (Q6).

5 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial organiza-se em três níveis com funções distintas: uma teoria do problema, que explica por que a vulnerabilidade é territorial e socialmente produzida; uma teoria da intervenção, que explica como a metodologia pretende agir; e uma perspectiva avaliativa, que define como a pesquisa vai examiná-la. A seção termina com a teoria inicial do programa, que é o ponto de partida da análise.

5.1 DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE E TERRITÓRIO USADO

A epidemiologia crítica latino-americana compreende o processo saúde-doença como expressão das formas de vida coletivas e das relações de produção e reprodução social (LAURELL, 1982; BREILH, 2006). No Brasil, essa perspectiva sustentou a Reforma Sanitária e a concepção ampliada de saúde do SUS (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007; PAIM, 2018). Para apreendê-la empiricamente, o estudo adota a categoria de território usado de Milton Santos (2002): o espaço como unidade entre a materialidade e as ações de quem o habita, atravessado por verticalidades, que impõem lógicas externas, e por horizontalidades, as solidariedades e redes construídas localmente. A vulnerabilidade será tratada como processo histórico e espacialmente desigual, e não como atributo das comunidades.

Para dimensionar esses processos no nível dos domicílios, o estudo adota o referencial da Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde da Organização Mundial da Saúde (SOLAR; IRWIN, 2010). Ele distingue os determinantes estruturais, que estratificam a sociedade segundo renda, escolaridade, ocupação, classe social, gênero e raça ou etnia, dos determinantes intermediários: as circunstâncias materiais, como moradia, alimentação e ambiente; as circunstâncias psicossociais, como estressores e apoio social; os comportamentos; e o próprio sistema de saúde. A coesão e o capital social atravessam os dois níveis. Esse referencial não substitui a perspectiva da determinação social: oferece uma grade operacional para o questionário, enquanto a interpretação dos achados permanece ancorada na produção histórica e territorial das desigualdades.

5.2 VIGILÂNCIA POPULAR, EDUCAÇÃO POPULAR E COPRODUÇÃO DO CONHECIMENTO

A vigilância popular em saúde distingue-se da vigilância institucional por reconhecer os moradores como sujeitos da observação, da interpretação e da ação sobre o território, e não como fontes de dados (MACHADO et al., 2024; OLIVEIRA et al., 2024). Seu fundamento pedagógico está na educação popular de Paulo Freire (1987), que concebe o conhecimento como produção dialógica a partir da leitura do mundo, e na investigação-ação participativa de Fals Borda (1985), que articula investigação, educação e ação. A noção de comunidade de pares estendida, da ciência pós-normal, legitima a ampliação dos produtores de conhecimento em situações de alta incerteza e valores em disputa (FUNTOWICZ; RAVETZ, 1993).

Esse referencial impõe à pesquisa uma exigência e um cuidado. A exigência é tratar o conhecimento comunitário como conhecimento, e não como opinião a ser validada pela ciência. O cuidado é não converter participação em sinônimo de emancipação: a análise examinará quem fala, quem é ouvido, quem decide e quem paga o custo da participação.

5.3 REDES SOCIOTÉCNICAS, TRADUÇÃO E GOVERNANÇA PARTICIPATIVA

A metodologia da PICAPS começa pela ativação de redes sociotécnicas. A teoria dos laços fracos explica por que atores-ponte entre grupos são decisivos para a circulação de informação nova (GRANOVETTER, 1973). A sociologia da tradução descreve como um conjunto heterogêneo de atores passa a agir em conjunto quando seus interesses são problematizados, negociados e alinhados, e como essa rede pode se desfazer quando os porta-vozes perdem legitimidade (CALLON, 1986). A cartografia social e o Plano Popular podem ser lidos como objetos-fronteira: artefatos suficientemente estáveis para circular entre moradores, profissionais e gestores, e suficientemente flexíveis para serem interpretados por cada um segundo suas necessidades (STAR; GRIESEMER, 1989).

A governança participativa, por fim, é entendida como a capacidade de um espaço coletivo de deliberar e de influenciar decisões que não controla diretamente (TRAD; ESPERIDIÃO, 2009). Nas Salas de Cooperação Social, essa capacidade se expressa em duas funções: a vigilância popular, que produz e encaminha alertas, e a articulação do Plano Popular, que leva as prioridades do território às instâncias de decisão, segundo a lógica do planejamento estratégico situacional (MATUS, 1987; FIOCRUZ BRASÍLIA, 2026b).

5.4 AVALIAÇÃO DE PROCESSO E ABORDAGEM REALISTA

A perspectiva avaliativa combina duas tradições. A avaliação de processo de intervenções complexas examina a implementação (o que foi feito, com que fidelidade e com que adaptações), os mecanismos de impacto (como os participantes respondem à intervenção) e o contexto (o que facilita ou impede o funcionamento) (MOORE et al., 2015). A avaliação realista acrescenta uma forma de explicar: os programas não produzem resultados por si, mas oferecem recursos que desencadeiam mecanismos, isto é, raciocínios e respostas das pessoas, que só operam em determinados contextos; a explicação toma a forma de configurações contexto–mecanismo–resultado (PAWSON; TILLEY, 1997).

A adoção dessa abordagem tem uma consequência prática: o estudo parte de uma teoria inicial do programa, formulada a partir dos documentos da PICAPS e da literatura, e a revisa sistematicamente com os dados de campo. A teoria inicial não é uma hipótese a confirmar, mas um conjunto de proposições explicitamente refutáveis. O Quadro 1 apresenta essa teoria, incluindo explicações rivais.

Quadro 1 – Teoria inicial do programa: configurações contexto-mecanismo-resultado

Etapa	Contexto (C)	Mecanismo (M)	Resultado esperado (R)	Explicação rival
Ativação da rede	Organizações comunitárias ativas e lideranças-ponte entre grupos	Reconhecimento e confiança: os atores percebem o processo como seu	Adesão à cartografia de grupo diverso	Captura por lideranças já dominantes; exclusão de grupos sem organização
Cartografia e Plano Popular	Escuta efetiva e tradução de saberes (MTEI e Matriz UIC)	Sentido de autoria coletiva	Plano reconhecido como legítimo pelos moradores	Plano percebido como produto técnico da equipe externa
Formação dos pesquisadores populares	Formação dialógica com o mesmo grupo da cartografia	Autoeficácia e identidade de pesquisador popular	Permanência e atuação regular	Sobrecarga, ausência de remuneração e desistência
Vigilância popular	Fluxo pactuado com a UBS e interlocutor nomeado no serviço	Credibilidade mútua: o serviço reconhece o alerta; o pesquisador percebe retorno	Resposta documentada e continuidade dos registros	Ausência de retorno gera descrédito e abandono dos registros

Etapa	Contexto (C)	Mecanismo (M)	Resultado esperado (R)	Explicação rival
Articulação do Plano Popular	Acesso a decisores e janelas de oportunidade	Legitimidade política da Sala como porta-voz do território	Ações do Plano incorporadas à agenda da gestão	Cooptação ou conflito com a gestão; retaliação a lideranças

Fonte: Elaboração própria (2026), com base em FIOCRUZ BRASÍLIA (2026a; 2026b) e Pawson e Tilley (1997).

6 METODOLOGIA

6.1 TIPO DE ESTUDO E DESENHO

Trata-se de um **estudo de caso de métodos mistos com predominância qualitativa** (FETTERS; CURRY; CRESWELL, 2013; CRESWELL; PLANO CLARK, 2018), que articula dois componentes. O componente qualitativo é um estudo de caso longitudinal com unidades de análise incorporadas (YIN, 2015), conduzido como avaliação de processo informada pela abordagem realista (MOORE et al., 2015; PAWSON; TILLEY, 1997) e com componente participativo nos ciclos de interpretação e devolutiva (THIOLLENT, 2011). O componente quantitativo é um **inquérito domiciliar transversal, de base populacional**, com questionário misto, isto é, com questões estruturadas e abertas, que dimensiona os determinantes sociais da saúde nos quatro setores no início da implantação. O caso é a implementação da metodologia no Sol Nascente/Pôr do Sol; as unidades incorporadas são os quatro setores, cada um com sua rede ativada, seu Plano Popular e sua Sala de Cooperação Social. A dimensão longitudinal consiste em acompanhar os mesmos participantes, espaços e episódios em três ondas de produção de dados, ancoradas nos marcos da intervenção em cada setor, o que permite analisar mudanças e trajetórias, e não apenas retratos sucessivos (SALDAÑA, 2003; NEALE, 2019).

A predominância qualitativa é deliberada. O inquérito não mede o efeito da metodologia: será aplicado uma única vez, no início, para dimensionar as condições em que a metodologia opera, situar os processos participativos diante da distribuição dos determinantes e apoiar a seleção de participantes do componente qualitativo. Repeti-lo ao final para comparar prevalências induziria leituras causais que um território único, sem grupo de comparação, não sustenta.

Duas outras escolhas de desenho precisam ser explicitadas. A primeira refere-se à pesquisa-ação. A ação estudada, isto é, a implantação da metodologia, é conduzida pelo CTIS e pelos atores do território, e não pela equipe de pesquisa. Por isso, o estudo não se define como pesquisa-ação em sentido estrito. O componente participativo está nas oficinas de interpretação, em que achados parciais retornam às Salas e podem reorientar a implementação. Essas reorientações não são tratadas como viés a eliminar: são registradas em um diário de efeitos da pesquisa sobre a intervenção e analisadas como parte do objeto.

A segunda escolha refere-se à comparação externa. Versões anteriores do projeto previam um território-espelho. Num desenho qualitativo, um território sem intervenção não oferece trajetórias a reconstruir nem Salas a observar, e sua inclusão imporia custos éticos e logísticos sem ganho analítico. Ele foi, portanto, **excluído**. A comparação analítica ocorre entre os quatro setores, que entram na intervenção em momentos diferentes e tendem a apresentar contextos distintos, e entre episódios com desfechos contrastantes.

6.2 A INTERVENÇÃO ESTUDADA

A intervenção será descrita segundo o checklist TIDieR (HOFFMANN et al., 2014), a partir do Manual Técnico-Operacional dos DPT (FIOCRUZ BRASÍLIA, 2026a) e do Protocolo de Inteligência Territorial (FIOCRUZ BRASÍLIA, 2026b). Suas seis etapas são implantadas integralmente em cada setor, em ordem definida por sorteio e em degraus trimestrais, conforme o planejamento da PICAPS:

a) **Etapa 1** – ativação das redes sociotécnicas do setor, por mapeamento sociométrico de movimentos sociais, lideranças e coletivos, com pacto dialógico;

b) **Etapa 2** – diagnóstico multidimensional segundo as cinco dimensões dos DPT, realizado com a rede ativada;

c) **Etapa 3** – cartografia social participativa, tendo a rede ativada como público-base;

d) **Etapa 4** – elaboração e pactuação do Plano Popular;

e) **Etapa 5** – formação dos pesquisadores populares, recrutados entre os participantes da cartografia;

f) **Etapa 6** – instalação e operação da Sala de Cooperação Social, na qual os pesquisadores populares exercem a vigilância popular em saúde e a defesa, promoção e articulação para a efetivação do Plano Popular.

Antes do início do campo, será elaborado um guia descritivo dos componentes, que registra o que foi previsto e permite documentar o que efetivamente ocorreu. Será distinguida a implantação formal de cada componente de seu funcionamento efetivo, e adaptações, interrupções e controvérsias serão registradas com suas justificativas.

6.3 CENÁRIO, CASO E UNIDADES DE ANÁLISE

O cenário é o Sol Nascente/Pôr do Sol, na Região de Saúde Oeste do Distrito Federal. Os quatro setores serão acompanhados com o mesmo protocolo, mas com intensidade diferente de observação. Os dois primeiros setores na ordem de implantação, que terão o maior tempo de operação da Sala dentro do horizonte do estudo (cerca de 21 e 18 meses), receberão **acompanhamento intensivo**, com observação de todas as reuniões deliberativas. Os outros dois receberão **acompanhamento extensivo**, com observação de uma a cada duas reuniões. Essa decisão privilegia a fase de consolidação, que só pode ser observada onde a Sala opera por mais tempo, sem abandonar a variação entre setores.

6.4 PARTICIPANTES E AMOSTRAGEM

A amostragem será intencional, orientada pela relevância analítica e pela diversidade, e não pela representatividade estatística. O tamanho previsto foi estimado pelo critério de poder informacional, que considera a especificidade do objetivo, a densidade dos participantes em relação à pergunta, o uso de teoria, a qualidade do diálogo e a estratégia de análise (MALTERUD; SIERSMA; GUASSORA, 2016). Por se tratar de estudo longitudinal com várias fontes por episódio, o poder informacional cresce com o acompanhamento repetido dos mesmos participantes, o que justifica painéis menores com várias entrevistas por pessoa. O Quadro 2 apresenta as estimativas, que serão revistas ao longo do campo com justificativa registrada.

Quadro 2 – Participantes, critérios de inclusão e estimativas de entrevistas

Grupo	Critérios de inclusão	Pessoas	Ondas	Entrevistas
Pesquisadores populares (painel)	Formados na Etapa 5; 18 anos ou mais; diversidade de gênero, idade, trajetória de militância e intensidade de atuação	12 (3 por setor)	01, 02, 03	36

Grupo	Critérios de inclusão	Pessoas	Ondas	Entrevistas
Rede ativada que não se tornou pesquisador popular, lideranças e moradores	18 anos ou mais; inclui quem se afastou, críticos, pessoas pouco envolvidas e moradores selecionados entre respondentes do inquérito	12 (3 por setor)	01, 03	24
Profissionais de APS e de Vigilância em Saúde	Atuação nas equipes de Saúde da Família ou na vigilância de referência do setor	12 (3 por setor)	02, 03	24
Gestores da SES-DF e da Região de Saúde Oeste	Responsabilidade sobre a APS ou a vigilância do território	4	02, 03	8
Equipe de implementação do CTIS	Facilitadores e supervisores da metodologia nos setores	4	02, 03	8
Total estimado		44		100

Fonte: Elaboração própria (2026).

Além do painel, serão realizadas entrevistas de saída com pesquisadores populares que deixarem a função, porque o afastamento é informação central sobre a sustentabilidade da metodologia. Os moradores que não integram as redes ativadas serão selecionados, em parte, entre os respondentes do inquérito domiciliar que autorizarem novo contato, segundo perfis contrastantes de determinantes sociais da saúde (seção 6.7). Não serão incluídos menores de 18 anos como participantes da pesquisa. A recusa ou a desistência não acarretará qualquer prejuízo no acesso a serviços, na participação nas atividades da PICAPS ou nas relações de trabalho.

6.5 ONDAS LONGITUDINAIS E PRODUÇÃO DE DADOS QUALITATIVOS

As ondas são definidas por marcos da intervenção, e não por datas fixas, para que os setores sejam comparados em momentos equivalentes de sua trajetória. O Quadro 3 apresenta o calendário previsto, que acompanhará eventuais ajustes no cronograma da implantação.

Quadro 3 – Ondas de produção de dados por setor (meses do projeto)

Setor (ordem de implantação)	Onda 1 – ativação e cartografia (Etapas 1 a 3)	Onda 2 – início da Sala (1 a 3 meses de operação)	Onda 3 – consolidação (9 a 12 meses de operação)
1º setor (intensivo)	M7–M9	M13–M15	M22–M24
2º setor (intensivo)	M10–M12	M16–M18	M25–M27
3º setor (extensivo)	M13–M15	M19–M21	M28–M30
4º setor (extensivo)	M16–M18	M22–M24	M31–M33

Fonte: Elaboração própria (2026), com base no calendário de implantação faseada da PICAPS.

Serão empregados cinco procedimentos de produção de dados:

a) **entrevistas semiestruturadas**, com roteiros específicos por grupo e por onda (Apêndice A), gravadas em áudio mediante consentimento e transcritas na íntegra; na segunda e na terceira ondas, os roteiros retomam o que o participante relatou anteriormente, para explorar mudanças;

b) **observação participante** das reuniões deliberativas das Salas, das oficinas de cartografia social e de elaboração do Plano Popular (ao menos duas por setor) e de encontros da formação (dois por turma), registrada em diário de campo com roteiro padronizado (Apêndice B); estimam-se cerca de 52 reuniões de Sala observadas;

c) **análise documental** de atas, Relatórios de Ciclo, Planos Populares, mapas da cartografia social, materiais formativos, registros agregados de alertas e encaminhamentos da Plataforma Ágora e documentos institucionais da SES-DF;

d) **rastreamento de trajetórias**: reconstrução de 24 episódios (seis por setor), selecionados de forma estratificada entre alertas da vigilância popular e demandas do Plano Popular, garantindo que ao menos um terço deles não tenha recebido resposta; cada episódio é reconstruído por documentos e por entrevistas curtas com os atores envolvidos, em ficha própria (Apêndice C);

e) **oficinas de interpretação** com cada Sala após a segunda e a terceira ondas (oito no total), nas quais achados parciais são discutidos com os participantes.

6.6 INQUÉRITO DOMICILIAR SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE

6.6.1 Desenho, população e amostra

A população do inquérito são os domicílios particulares permanentes ocupados dos quatro setores. Em cada domicílio será entrevistado um morador de 18 anos ou mais, preferencialmente a pessoa responsável ou seu cônjuge, que responderá aos blocos sobre o domicílio e sobre si mesmo. A amostragem será probabilística por conglomerados, em dois estágios, estratificada pelos quatro setores. No primeiro estágio, setores censitários do Censo Demográfico 2022 serão sorteados com probabilidade proporcional ao número de domicílios. No segundo, os domicílios serão selecionados por amostragem sistemática a partir de listagem atualizada em campo, procedimento recomendado para áreas de ocupação irregular, onde os cadastros oficiais são incompletos (ALVES et al., 2011).

O tamanho da amostra foi calculado para estimar, em cada setor, uma prevalência de 50%, cenário de maior variância, com precisão absoluta de 10 pontos percentuais e confiança de 95%, o que resulta em 96 domicílios (LWANGA; LEMESHOW, 1991). A fórmula aplicada é $n = [z^2 \times P(1 - P) / d^2] \times deff \div (1 - perda)$. Com efeito de desenho de 1,5 e perda de 30%, valores compatíveis com inquéritos domiciliares brasileiros recentes (RODRIGUES et al., 2021), chega-se a cerca de 210 domicílios por setor e 840 no total, distribuídos em aproximadamente 11 setores censitários por setor do território, com cerca de 20 domicílios cada. Para o conjunto do território, essa amostra permite estimar prevalências com precisão aproximada de 5 pontos percentuais.

6.6.2 Questionário

O questionário foi construído a partir do referencial da Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde da OMS (SOLAR; IRWIN, 2010), apresentado na seção 5.1. A seleção dos itens seguiu três critérios, nesta ordem de prioridade: itens de inquéritos oficiais brasileiros, que permitem comparar o território com o Distrito Federal e com o país; escalas com validação no Brasil; e itens adaptados ou elaborados pela equipe somente para dimensões sem instrumento disponível, sempre submetidos a teste cognitivo.

Ferramentas internacionais de triagem de necessidades sociais, como o PRAPARE (NACHC, 2016) e a ferramenta do modelo *Accountable Health Communities* (BILLIOUX et al., 2017), foram examinadas e não adotadas como base. Elas foram concebidas para triagem individual em serviços clínicos, parte de seus itens tem restrições de licença e, como mostra revisão sistemática, a maioria das ferramentas de triagem de risco social tem evidência psicométrica muito limitada (HENRIKSON et al., 2019). Seus

domínios, porém, orientaram a inclusão de itens sobre contas atrasadas, cortes de serviços e transporte.

Os instrumentos de origem são: a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), em sua versão de 14 itens usada pelo IBGE, que classifica o domicílio em segurança ou insegurança alimentar leve, moderada ou grave e permite comparação com as estimativas nacionais (IBGE, 2020; 2025), reproduzida no Anexo A; o Critério de Classificação Econômica Brasil 2026 (ABEP, 2026), reproduzido no Anexo B; itens dos módulos de domicílio, Estratégia Saúde da Família, percepção do estado de saúde, doenças crônicas e apoio social da Pesquisa Nacional de Saúde 2019 (IBGE, 2021); itens de entorno da PDAD-A 2023, como alagamento e esgoto a céu aberto (IPEDF, 2023); a versão de quatro itens da escala HWISE de insegurança hídrica (YOUNG et al., 2019; 2021); itens de coesão social, segurança e violência adaptados das escalas de vizinhança validadas no ELSA-Brasil (SANTOS, S. M. et al., 2013); e situações e motivos de discriminação adaptados da Escala de Discriminação Explícita (BASTOS et al., 2012), com inclusão explícita do local de moradia entre os motivos, dado o estigma territorial que recai sobre o Sol Nascente.

O questionário (Apêndice D) tem 13 blocos, 99 itens estruturados, dos quais 14 da EBIA, e seis questões abertas, com duração estimada de 35 a 40 minutos, a confirmar no piloto. O Quadro 4 relaciona as dimensões medidas aos níveis do referencial e aos instrumentos de origem.

Quadro 4 – Dimensões do questionário, níveis do referencial e instrumentos de origem

Nível (Solar e Irwin)	Dimensão	Bloco	Itens	Instrumentos de origem
Estrutural	Posição socioeconômica: escolaridade, cor ou raça, gênero, trabalho, renda e proteção social	B, C	21	IBGE; PNS 2019; PDAD-A 2023; ABEP 2026; itens próprios
Intermediário – material	Moradia, saneamento, entorno e bens do domicílio	D	21	PNS 2019; PDAD-A 2023; ABEP 2026; itens próprios
Intermediário – material	Insegurança hídrica	E	4	HWISE-4 (tradução a adaptar)
Intermediário – material	Insegurança alimentar	F	15	EBIA (14 itens); item próprio
Intermediário – psicossocial	Coesão social, segurança e violência na vizinhança	G	9	ELSA-Brasil (adaptado); itens próprios
Transversal – coesão e capital social	Apoio social, participação comunitária e conhecimento da PICAPS	H	10	PNS 2019 (módulo M); itens próprios
Intermediário – psicossocial	Discriminação	I	7	EDE (adaptada)
Sistema de saúde	Saúde autorreferida, cadastro na ESF, visitas do ACS, acesso e barreiras	J	10	PNS 2019; itens próprios
Intermediário – material	Acesso digital	K	2	PNS 2019 (adaptado); item próprio
Percepções e experiências	Questões abertas	L	6	Elaboradas pela equipe

Fonte: Elaboração própria (2026).

As seis questões abertas têm finalidades definidas antes da coleta, como recomenda a literatura sobre perguntas abertas em questionários (O'CATHAIN; THOMAS, 2004). Quatro buscam profundidade sobre os problemas percebidos, as experiências com os serviços e os caminhos de resolução de problemas no

bairro, e se conectam às questões Q3 e Q4. Uma pede a prioridade que o morador levaria aos serviços, para comparação com o Plano Popular. A última funciona como rede de segurança para temas não previstos. As respostas serão registradas literalmente.

Não foram incluídas perguntas sobre violência doméstica ou sexual. Em entrevista domiciliar, frequentemente na presença de outros moradores, essas perguntas exigiriam protocolo específico de privacidade e de resposta que o desenho não comporta; a violência é abordada no nível da vizinhança.

6.6.3 Adaptação, pré-teste e coleta

Os itens traduzidos da escala HWISE seguirão as etapas de adaptação transcultural propostas por Beaton et al. (2000): duas traduções independentes, síntese, retrotradução, revisão por comitê de especialistas e pré-teste. Todo o questionário passará por entrevistas cognitivas (WILLIS, 2005) com cerca de 30 moradores de perfis diversos, incluindo pesquisadores populares, para verificar a compreensão dos itens, a adequação das escalas de resposta e a sensibilidade das perguntas. Essa etapa é indispensável em populações pouco familiarizadas com questionários padronizados, nas quais escalas de concordância e conceitos abstratos costumam ser mal compreendidos (MASSEY, 2025). Seguir-se-á um piloto em 40 domicílios fora da amostra.

As entrevistas serão realizadas face a face por entrevistadores contratados e treinados pela equipe da UnB, com coleta em tablets pelo aplicativo KoboToolbox; a coleta eletrônica tende a reduzir erros e dados faltantes em relação ao papel (ZELEKE et al., 2021). Os pesquisadores populares não atuarão como entrevistadores, por duas razões: são agentes da intervenção cujos processos o estudo avalia, e perguntas sobre renda, fome e discriminação feitas por vizinhos podem inibir respostas ou expor informações no território. Eles participarão, contudo, das entrevistas cognitivas, da adaptação das questões abertas e da interpretação dos resultados. Serão feitas até três visitas por domicílio antes de se registrar ausência, e a supervisão revisará diariamente os dados recebidos. O inquérito será realizado entre os meses 7 e 10, na ordem de implantação dos setores, de modo que os resultados preliminares de cada setor estejam disponíveis antes de sua cartografia social.

6.6.4 Análise do inquérito

As estimativas considerarão o plano amostral complexo, com estratos, conglomerados e pesos amostrais ajustados por não resposta e calibrados pela distribuição de sexo e idade do Censo 2022, no ambiente R. Serão estimadas prevalências e médias, com intervalos de confiança de 95%, para cada dimensão, por setor e segundo sexo, cor ou raça e faixa etária do respondente. As escalas com manual de pontuação (EBIA, Critério Brasil e HWISE-4) serão pontuadas segundo suas regras; para os itens adaptados, a consistência interna será examinada antes de qualquer escore agregado. Associações entre os determinantes e a autoavaliação de saúde serão exploradas por regressão de Poisson com variância robusta, como análise descritiva e geradora de hipóteses, sem pretensão causal. Não será construído um índice sintético de determinantes: as dimensões serão apresentadas separadamente, para que a leitura do território não dependa de pesos arbitrários.

As respostas abertas serão submetidas a análise de conteúdo, com livro de códigos que combina categorias derivadas dos domínios do referencial da OMS e categorias indutivas. Dois codificadores codificarão independentemente 20% das respostas para consolidar o livro de códigos. As categorias serão transformadas em variáveis para cruzamento com os itens estruturados, e os trechos mais densos alimentarão o componente qualitativo (O'CATHAIN; THOMAS, 2004; SINGER; COUPER, 2017).

6.7 INTEGRAÇÃO ENTRE OS COMPONENTES

A integração ocorrerá nos três níveis descritos por Fetters, Curry e Creswell (2013): desenho, métodos e interpretação. No nível dos métodos, o inquérito se **conecta** ao componente qualitativo pela amostragem, pois parte dos moradores entrevistados nas ondas qualitativas será selecionada entre os respondentes que autorizarem novo contato, segundo perfis contrastantes de determinantes. O inquérito também **alimenta** a cartografia social e os roteiros de entrevista, ao devolver às redes ativadas o retrato dos determinantes de cada setor. Por fim, é **combinado** aos dados qualitativos em *joint displays* por setor (GUETTERMAN; FETTERS; CRESWELL, 2015). No nível da interpretação, cada achado integrado será classificado como confirmação, expansão ou discordância. As discordâncias, como um determinante muito prevalente que não aparece no Plano Popular, serão tratadas como achados a explicar, e não como erro de um dos componentes. O Quadro 5 sintetiza essas estratégias.

Quadro 5 – Estratégias de integração entre o inquérito e o componente qualitativo

Estratégia	Como ocorre neste estudo	Questões
Conexão	Seleção intencional de moradores para as entrevistas qualitativas entre respondentes que autorizarem novo contato, segundo perfis de determinantes, como insegurança alimentar grave, insegurança hídrica e discriminação por local de moradia	Q2, Q3
Construção	Devolução dos resultados preliminares de cada setor às redes ativadas antes da cartografia social; uso das respostas abertas para ajustar os roteiros de entrevista	Q3
Combinação	Joint displays por setor que cruzam prevalências dos determinantes, problemas priorizados no Plano Popular e trajetórias de alertas e demandas	Q1, Q3, Q4
Interpretação	Classificação explícita de cada achado integrado como confirmação, expansão ou discordância, com registro das metainferências	Q6

Fonte: Elaboração própria (2026), com base em Fetters, Curry e Creswell (2013).

6.8 ANÁLISE DOS DADOS QUALITATIVOS

A análise será conduzida pelo *método* framework** *(GALE et al., 2013), adequado a estudos com várias fontes, várias unidades de caso e questões previamente definidas, porque permite comparar casos e temas sem perder o contexto de cada relato. O método segue cinco passos: familiarização com o material; codificação inicial, que combina códigos derivados da teoria do programa (Quadro 1) com códigos indutivos; construção do quadro analítico; indexação de todo o corpus; e organização dos dados em matrizes. As matrizes cruzam participantes ou episódios (linhas) com temas (colunas), em cada onda, e serão mantidas no* software* MAXQDA.

A dimensão temporal será analisada por duas estratégias complementares (GROSSOEHME; LIPSTEIN, 2016): a análise **transversal recorrente**, que compara os temas entre as ondas para identificar o que muda no conjunto; e a análise de **trajetórias**, que acompanha cada participante e cada episódio ao longo do tempo para identificar como e por que suas posições mudam. As perguntas de Saldaña (2003) sobre o que aumenta, diminui, surge, cessa ou permanece orientarão essa leitura.

Para responder à questão dos mecanismos (Q6), as matrizes serão usadas para formular e testar configurações contexto–mecanismo–resultado, por raciocínio retrodutivo: a partir de um resultado observado, pergunta-se que mecanismo o explicaria e em que contexto ele operou, confrontando a

explicação com as rivais do Quadro 1 e com casos negativos (PAWSON; TILLEY, 1997). A teoria inicial será revista ao final de cada onda, e cada revisão será documentada com as evidências que a motivaram.

Dois pesquisadores codificarão de forma independente cerca de 20% do material da primeira onda, para calibrar o quadro analítico. As divergências serão discutidas até a definição consensual dos códigos. O objetivo dessa dupla codificação é refinar categorias e expor pressupostos, e não calcular coeficientes de concordância, que não são compatíveis com a lógica interpretativa da análise.

6.9 RIGOR, REFLEXIVIDADE E INDEPENDÊNCIA ANALÍTICA

O rigor será assegurado pelos critérios de confiabilidade da pesquisa qualitativa (LINCOLN; GUBA, 1985), operacionalizados conforme o Quadro 6. O relato seguirá os padrões SRQR (O'BRIEN et al., 2014) e, para entrevistas, o COREQ (TONG; SAINSBURY; CRAIG, 2007).

Quadro 6 – Critérios de rigor e procedimentos correspondentes

Critério	Procedimentos
Credibilidade	Permanência prolongada no campo; triangulação de entrevistas, observação, documentos, trajetórias e inquérito; busca ativa de casos negativos; oficinas de interpretação com os participantes
Transferibilidade	Descrição densa do território, dos setores e da intervenção (TIDieR); explicitação dos critérios de seleção de participantes e episódios
Dependabilidade	Protocolo e roteiros versionados; registro de todas as alterações no quadro analítico; trilha de auditoria revisada por analista externo à implementação
Confirmabilidade	Diários reflexivos da equipe; separação entre equipe de campo e equipe de implementação; apresentação de evidência empírica para cada interpretação

Fonte: Elaboração própria (2026).

A independência analítica é o ponto mais sensível do estudo, porque o CTIS concebe e implementa a metodologia. Para enfrentá-lo, adotam-se três regras. A primeira é a **separação de equipes**: as entrevistas, a observação e a codificação serão realizadas por pesquisadores vinculados à UnB, sem função na implementação; a equipe do CTIS participa do desenho e das discussões interpretativas, mas não entrevista pesquisadores populares nem profissionais e não tem acesso a dados identificados. A coleta e a análise do inquérito também ficam a cargo da equipe da UnB. A segunda é a **revisão externa**: um analista sem vínculo com a PICAPS revisará a trilha de auditoria e as interpretações ao final de cada onda, mediante termo de compromisso a ser firmado antes do início do campo. A terceira é a **ausência de veto**: as devolutivas servem para corrigir erros factuais e registrar divergências, mas nenhum participante ou instituição poderá vetar achados críticos ou desfavoráveis.

6.10 MATRIZ DE CONSISTÊNCIA

O Quadro 7 articula cada questão de pesquisa ao objetivo, às fontes e à estratégia de análise correspondentes.

Quadro 7 – Matriz de consistência do estudo

Questão	Objetivo	Fontes principais	Estratégia de análise
Q1 – distribuição dos determinantes sociais da saúde	OE1	Inquérito domiciliar (blocos B a K); questões abertas (bloco L)	Estimativas com plano amostral complexo; análise de conteúdo das respostas abertas; joint displays por setor
Q2 – ativação da rede e constituição do grupo	OE2	Entrevistas com rede, pesquisadores populares e equipe; entrevistas de saída; mapas sociométricos; observação das Etapas 1 a 5	Matrizes por setor e onda; trajetórias de participação
Q3 – identificação e priorização de problemas	OE3	Observação da cartografia e do Plano; documentos; entrevistas; questões abertas do inquérito	Comparação entre categorias comunitárias e institucionais e com o dimensionamento dos determinantes; análise transversal recorrente
Q4 – trajetórias de alertas e demandas	OE4	Rastreamento de 24 episódios; registros da Plataforma Ágora; entrevistas com profissionais e gestores	Reconstrução de episódios; comparação entre episódios com e sem resposta
Q5 – governança nas Salas	OE5	Observação das reuniões; atas e Relatórios de Ciclo; entrevistas de todos os grupos	Análise de trajetórias da Sala; relações de poder e legitimidade
Q6 – mecanismos e efeitos não previstos	OE6	Todas as fontes; oficinas de interpretação; diário de efeitos da pesquisa	Configurações contexto-mecanismo-resultado por retrodução; teste de explicações rivais

Fonte: Elaboração própria (2026).

6.11 DADOS SECUNDÁRIOS DE CONTEXTO

Indicadores de saúde e de condições de vida do território (por exemplo, internações por condições sensíveis à APS, captação precoce de gestantes e indicadores socioambientais) serão usados apenas para descrever o contexto e para formular perguntas ao campo; a fonte principal sobre os determinantes sociais da saúde é o inquérito domiciliar. Não serão interpretados como medida de efeito da metodologia. Do mesmo modo, o Índice de Vulnerabilidade Territorial Ampliado (IVT+A) não é desfecho deste estudo. Se o índice for calculado pela PICAPS, a pesquisa examinará como ele é produzido e usado nas Salas, com atenção ao risco de circularidade: quando componentes do índice derivam de atividades da própria intervenção, como reuniões ou alertas, sua variação pode refletir maior registro, e não menor vulnerabilidade.

7 ASPECTOS ÉTICOS

7.1 MARCO NORMATIVO E TRAMITAÇÃO

O protocolo será submetido pela Plataforma Brasil ao Comitê de Ética em Pesquisa da Fiocruz Brasília, como instituição proponente, com a SES-DF e a UnB como instituições coparticipantes. A pesquisa observará a Lei nº 14.874/2024 e o Decreto nº 12.651/2025, que instituem o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (BRASIL, 2024; 2025), e a Resolução CNS nº 510/2016, aplicável às pesquisas com metodologias próprias das Ciências Humanas e Sociais (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2016), complementada pela Resolução CNS nº 466/2012 (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012), que permanecem válidas no que não contrariarem a nova legislação. Nenhuma atividade de produção de dados com participantes será iniciada antes da aprovação ética.

7.2 CONSENTIMENTO

O consentimento livre e esclarecido será obtido de cada participante entrevistado, com registro escrito ou, quando a escrita for inadequada à situação do participante, em áudio, nos termos da Resolução CNS nº 510/2016, sempre com entrega de documento com as informações da pesquisa. Na observação das reuniões das Salas, a pesquisa será apresentada ao coletivo, que deliberará sobre a presença do pesquisador; qualquer pessoa poderá pedir que suas falas não sejam registradas no diário de campo. As reuniões não serão gravadas em áudio ou vídeo. No acompanhamento longitudinal, o consentimento será reconfirmado em cada onda. No inquérito domiciliar, o consentimento será registrado por escrito, em papel ou no tablet, antes da entrevista, com entrega de via ao participante. A autorização para novo contato, destinada à seleção de participantes do componente qualitativo, será solicitada separadamente ao final da entrevista, e os dados de contato serão armazenados apartados das respostas.

7.3 RISCOS E BENEFÍCIOS

A pesquisa é classificada como de risco baixo, de natureza psicossocial. Os riscos previstos e as respectivas medidas de mitigação são:

a) desconforto ao relatar conflitos, frustrações ou experiências de violência – mitigado pela liberdade de não responder e de interromper a entrevista e pelo encaminhamento à rede de atenção psicossocial quando necessário;

b) **coerção**, porque os pesquisadores populares são supervisionados pela equipe que implementa a metodologia e os profissionais têm vínculo com a SES-DF – mitigado pela realização das entrevistas por pesquisadores da UnB, sem relação hierárquica com os participantes, e pela garantia de que nenhuma informação individual será repassada ao CTIS ou à gestão;

c) exposição de conflitos locais e identificação de pessoas ou setores em publicações – mitigada pelo uso de pseudônimos, pela codificação dos setores (A a D) e pela supressão de detalhes que permitam reconhecer participantes;

d) exposição dos pesquisadores populares a conflitos decorrentes da articulação do Plano Popular – mitigada pela não divulgação de posicionamentos individuais e por análise de risco antes de qualquer publicação;

e) constrangimento ao responder sobre renda, fome e discriminação no inquérito – mitigado pela liberdade de não responder, pela realização da entrevista em local reservado sempre que possível e pela entrega, a todos os domicílios entrevistados, e não apenas aos que relatarem dificuldades, de folheto com os serviços de saúde, assistência social e proteção do território, o que evita estigmatizar quem responde;

f) riscos à segurança dos entrevistadores em áreas sob controle de grupos armados – mitigados por protocolo de segurança em campo, trabalho em duplas, mediação de lideranças locais para a entrada nos setores e suspensão da coleta em situações de risco.

Os benefícios diretos são a participação nas oficinas de interpretação e o acesso aos resultados. Os benefícios coletivos são o conhecimento sobre as condições que fazem a vigilância popular produzir resposta e as recomendações para o aprimoramento da metodologia e da articulação com os serviços. A participação não envolve custo nem remuneração; despesas de transporte e alimentação decorrentes da participação serão ressarcidas.

7.4 PROTEÇÃO DE DADOS

O tratamento de dados pessoais terá como base legal a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida a anonimização sempre que possível (art. 7º, inciso IV, e art. 11, inciso II, alínea "c", da Lei nº 13.709/2018) (BRASIL, 2018). Áudios e transcrições serão armazenados em servidor institucional com acesso restrito à equipe de campo; a chave que liga pseudônimos a identidades será guardada separadamente. A transcrição será feita pela equipe ou por serviço contratado sob termo de confidencialidade. Os registros da Plataforma Ágora serão acessados apenas de forma agregada ou desidentificada. Os dados serão mantidos por cinco anos após o término do estudo e então eliminados. Transcrições e dados brutos não serão publicados.

7.5 DEVOLUTIVA E GOVERNANÇA COMUNITÁRIA

Os resultados serão devolvidos a cada Sala de Cooperação Social em linguagem acessível, nas oficinas de interpretação e em uma devolutiva final, e às equipes de APS e à SES-DF em relatório técnico. As Salas serão consultadas sobre a forma de divulgação dos achados que envolvam o território, sem prejuízo das obrigações de proteção de dados e sem poder de veto sobre resultados científicos.

8 LIMITAÇÕES

a) **caso único**: os achados não se generalizam estatisticamente; sua transferência para outros territórios dependerá da descrição densa do contexto e da explicitação dos mecanismos;

b) **proximidade institucional**: mesmo com a separação de equipes, a vinculação da pesquisa à Fiocruz pode induzir respostas favoráveis; por isso a busca ativa de participantes críticos e afastados e a revisão externa;

c) **viés de atividade**: participantes mais ativos tendem a dominar entrevistas e reuniões; as entrevistas de saída e a inclusão de membros da rede que não se tornaram pesquisadores populares procuram corrigir esse viés;

d) **dependência do cronograma da intervenção**: atrasos na implantação deslocam as ondas e podem reduzir o tempo de observação dos últimos setores, o que será registrado e considerado na análise;

e) **efeito da própria pesquisa**: as oficinas de interpretação podem alterar a implementação; essas alterações serão documentadas e analisadas, e não ocultadas;

f) **percepção e efeito**: relatos de melhora são evidências sobre experiências e significados, e não comprovação de mudança nas condições de saúde;

g) **inquérito transversal único**: descreve a distribuição dos determinantes no início da implantação, mas não mede mudança nem efeito da metodologia;

h) **itens adaptados**: a escala HWISE-4 e os itens de coesão e de discriminação não têm validação prévia nessa população; passarão por entrevistas cognitivas e análise de consistência interna, e seus resultados serão interpretados com cautela;

i) **não resposta e sub-relato**: recusas e domicílios não encontrados podem chegar a 30% ou mais, e perguntas sensíveis tendem a ser sub-relatadas; pesos com ajuste por não resposta reduzem, mas não eliminam, esses vieses.

9 RESULTADOS ESPERADOS E PRODUTOS

Os resultados esperados são produtos de conhecimento, e não garantias de eficácia da metodologia:

a) perfil dos determinantes sociais da saúde em cada setor, com prevalências e intervalos de confiança, devolvido às redes ativadas e às Salas de Cooperação Social;

b) teoria do programa da metodologia revisada, com configurações contexto–mecanismo–resultado sustentadas por evidência empírica;

c) tipologia das trajetórias de alertas e demandas, com as condições associadas à resposta, à recusa e à ausência de resposta;

d) análise da constituição e da transformação das Salas de Cooperação Social como espaços de governança participativa;

e) recomendações à PICAPS, à SES-DF e às equipes de APS sobre a articulação entre Salas e serviços, cada uma rastreável às evidências que a sustentam;

f) protocolo de avaliação de processo, roteiros, guias de observação e questionário misto adaptado e testado, disponíveis para reaplicação em outros territórios, além da base anonimizada do inquérito, disponível mediante solicitação;

g) relatório técnico para a gestão, materiais de devolutiva em linguagem acessível e artigos científicos proporcionais ao material produzido.

10 CRONOGRAMA

O estudo terá duração de 36 meses, organizados em seis semestres (S1 a S6). As ondas qualitativas acompanham os marcos da implantação em cada setor (Quadro 3), e o inquérito ocorre no segundo semestre, antes da cartografia social de cada setor.

Quadro 8 – Cronograma de execução por semestre

Atividade	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Pactuação institucional, guia da intervenção e teoria inicial do programa	X					
Elaboração e teste dos instrumentos; submissão e aprovação ética	X					
Seleção e treinamento da equipe de campo e dos entrevistadores	X					
Adaptação, entrevistas cognitivas e piloto do questionário	X					
Listagem domiciliar e inquérito domiciliar		X				
Análise do inquérito e devolutiva por setor		X	X			
Onda 1 (ativação e cartografia)		X	X			
Onda 2 (início da operação das Salas)			X	X		
Onda 3 (consolidação das Salas)				X	X	X
Observação das Salas e oficinas		X	X	X	X	X
Rastreamento de trajetórias			X	X	X	X
Análise iterativa e revisão da teoria do programa		X	X	X	X	X
Integração dos componentes (joint displays)			X	X	X	X
Oficinas de interpretação				X	X	X
Relatório final, devolutiva final e artigos						X

Fonte: Elaboração própria (2026).

11 RECURSOS E ORÇAMENTO

O Quadro 9 apresenta as rubricas e as quantidades estimadas. Os valores serão definidos conforme a fonte de financiamento e deverão constar do formulário da Plataforma Brasil.

Quadro 9 – Orçamento estimado

Rubrica	Especificação e quantidade estimada	Valor (R$)
Bolsas de pesquisa	Dois pesquisadores de campo (UnB) por 30 meses; um bolsista de apoio por 24 meses	[a preencher]
Transcrição	Cerca de 100 entrevistas de aproximadamente 60 minutos	[a preencher]
Inquérito domiciliar	Seis entrevistadores e um supervisor por cerca de quatro meses (listagem, piloto e 840 entrevistas); seguro e identificação de campo	[a preencher]
Equipamentos do inquérito	Oito tablets; aplicativo de coleta de uso gratuito (KoboToolbox); impressão de folhetos de serviços	[a preencher]
Software e equipamentos	Licença MAXQDA para a equipe; gravadores digitais; armazenamento institucional seguro	[a preencher]
Deslocamento	Transporte da equipe ao território durante 27 meses de campo	[a preencher]
Ressarcimento de participantes	Transporte e alimentação para entrevistas e oito oficinas de interpretação	[a preencher]
Revisão externa	Analista independente para revisão da trilha de auditoria em três momentos	[a preencher]
Divulgação	Materiais de devolutiva e publicação em acesso aberto	[a preencher]
Total	Fonte de financiamento: [a preencher]	[a preencher]

Fonte: Elaboração própria (2026).

REFERÊNCIAS

ABEP – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE PESQUISA. **Critério de Classificação Econômica Brasil 2026**. São Paulo: ABEP, 2026.

ALVES, M. C. G. P. et al. Household sampling in slums in surveys. **Revista de Saúde Pública**, v. 45, n. 6, p. 1099-1109, 2011.

BASTOS, J. L. et al. Explicit discrimination and health: development and psychometric properties of an assessment instrument. **Revista de Saúde Pública**, v. 46, n. 2, p. 269-278, 2012.

BEATON, D. E. et al. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. **Spine**, v. 25, n. 24, p. 3186-3191, 2000.

BILLIOUX, A. et al. **Standardized screening for health-related social needs in clinical settings**: the Accountable Health Communities screening tool. Washington, DC: National Academy of Medicine, 2017. (NAM Perspectives. Discussion Paper).

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 18055, 20 set. 1990.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Lei nº 14.874, de 28 de maio de 2024. Dispõe sobre a pesquisa com seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 29 maio 2024.

BRASIL. Decreto nº 12.651, de 7 de outubro de 2025. Regulamenta a Lei nº 14.874, de 28 de maio de 2024. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 3, 8 out. 2025.

BREILH, J. **Epidemiologia crítica**: ciência emancipadora e interculturalidade. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006.

BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A. A saúde e seus determinantes sociais. **Physis**: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77-93, 2007.

CALLON, M. Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. In: LAW, J. (ed.). **Power, action and belief**: a new sociology of knowledge? London: Routledge, 1986. p. 196-223.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (Brasil). Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 13 jun. 2013.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (Brasil). Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 24 maio 2016.

CRESWELL, J. W.; PLANO CLARK, V. L. **Designing and conducting mixed methods research**. 3. ed. Thousand Oaks: Sage, 2018.

FALS BORDA, O. **Conocimiento y poder popular**: lecciones con campesinos de Nicaragua, México y Colombia. Bogotá: Punta de Lanza; Siglo XXI, 1985.

FETTERS, M. D.; CURRY, L. A.; CRESWELL, J. W. Achieving integration in mixed methods designs: principles and practices. **Health Services Research**, v. 48, n. 6, pt. 2, p. 2134-2156, 2013.

FIOCRUZ BRASÍLIA. **Manual técnico-operacional de diagnóstico situacional para territórios**: Diálogos Prospectivos Territoriais (DPT). Brasília: Fiocruz Brasília/PICAPS, 2026a.

FIOCRUZ BRASÍLIA. **Protocolo de Inteligência Territorial**. Brasília: Fiocruz Brasília/CoLaboratório CTIS/PICAPS, 2026b.

FIOCRUZ BRASÍLIA. **Diagnóstico situacional do Distrito Federal**. Brasília: Fiocruz Brasília/CoLaboratório CTIS, 2026c. (Série Diagnósticos Territoriais – PICAPS).

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FUNTOWICZ, S. O.; RAVETZ, J. R. Science for the post-normal age. **Futures**, v. 25, n. 7, p. 739-755, 1993.

GALE, N. K. et al. Using the framework method for the analysis of qualitative data in multi-disciplinary health research. **BMC Medical Research Methodology**, v. 13, art. 117, 2013.

GRANOVETTER, M. The strength of weak ties. **American Journal of Sociology**, v. 78, n. 6, p. 1360-1380, 1973.

GROSSOEHME, D.; LIPSTEIN, E. Analyzing longitudinal qualitative data: the application of trajectory and recurrent cross-sectional approaches. **BMC Research Notes**, v. 9, art. 136, 2016.

GUETTERMAN, T. C.; FETTERS, M. D.; CRESWELL, J. W. Integrating quantitative and qualitative results in health science mixed methods research through joint displays. **Annals of Family Medicine**, v. 13, n. 6, p. 554-561, 2015.

HENRIKSON, N. B. et al. Psychometric and pragmatic properties of social risk screening tools: a systematic review. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 57, n. 6, supl. 1, p. S13-S24, 2019.

HOFFMANN, T. C. et al. Better reporting of interventions: template for intervention description and replication (TIDieR) checklist and guide. **BMJ**, v. 348, g1687, 2014.

IBGE. **Pesquisa de orçamentos familiares 2017-2018**: análise da segurança alimentar no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2020.

IBGE. **Pesquisa Nacional de Saúde 2019**: manual de entrevista de saúde. Rio de Janeiro: IBGE, 2021.

IBGE. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua**: manual de segurança alimentar. Rio de Janeiro: IBGE, 2025.

IPEDF – INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. **Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada – PDAD-A 2023**: questionário. Brasília: IPEDF, 2023.

LAURELL, A. C. La salud-enfermedad como proceso social. **Revista Latinoamericana de Salud**, México, v. 2, p. 7-25, 1982.

LINCOLN, Y. S.; GUBA, E. G. **Naturalistic inquiry**. Beverly Hills: Sage, 1985.

LWANGA, S. K.; LEMESHOW, S. **Sample size determination in health studies**: a practical manual. Geneva: World Health Organization, 1991.

MACHADO, J. M. H. et al. Vigilância popular em saúde: conceitos, experiências e desafios no contexto brasileiro. **Interface**: Comunicação, Saúde, Educação, v. 28, e240304, 2024.

MALTERUD, K.; SIERSMA, V. D.; GUASSORA, A. D. Sample size in qualitative interview studies: guided by information power. **Qualitative Health Research**, v. 26, n. 13, p. 1753-1760, 2016.

MARTINS, W. J. et al. Plataforma de Inteligência Cooperativa com a Atenção Primária à Saúde (PICAPS): soluções tecnocientíficas em saúde digital no enfrentamento da COVID-19 e outras crises. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 10, e01622023, 2024.

MASSEY, M. Survey practice in non-survey-literate populations: lessons learned from a cognitive interview study in Brazil. **Survey Practice**, v. 19, 2025.

MATUS, C. **Política, planificación y gobierno**. Washington, DC: OPS/OMS, 1987.

MOORE, G. F. et al. Process evaluation of complex interventions: Medical Research Council guidance. **BMJ**, v. 350, h1258, 2015.

NACHC – NATIONAL ASSOCIATION OF COMMUNITY HEALTH CENTERS. **PRAPARE**: Protocol for Responding to and Assessing Patients' Assets, Risks, and Experiences. Bethesda: NACHC, 2016. Disponível em: https://prapare.org. Acesso em: 19 out. 2026.

NEALE, B. **What is qualitative longitudinal research?** London: Bloomsbury Academic, 2019.

O'BRIEN, B. C. et al. Standards for reporting qualitative research: a synthesis of recommendations. **Academic Medicine**, v. 89, n. 9, p. 1245-1251, 2014.

O'CATHAIN, A.; THOMAS, K. J. "Any other comments?" Open questions on questionnaires: a bane or a bonus to research? **BMC Medical Research Methodology**, v. 4, art. 25, 2004.

OLIVEIRA, S. S. et al. Vigilância popular em saúde: conceitos, experiências e potencialidades. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 5, 2024.

PAIM, J. S. Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, n. 6, p. 1723-1728, 2018.

PAWSON, R.; TILLEY, N. **Realistic evaluation**. London: Sage, 1997.

RODRIGUES, L. A. R. L. et al. Plano de amostragem e aspectos metodológicos: inquérito de saúde domiciliar no Piauí. **Revista de Saúde Pública**, v. 55, art. 118, 2021.

SALDAÑA, J. **Longitudinal qualitative research**: analyzing change through time. Walnut Creek: AltaMira Press, 2003.

SANTOS, M. **A natureza do espaço**: técnica e tempo, razão e emoção. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2002.

SANTOS, S. M. et al. Adaptação transcultural e confiabilidade de medidas de características autorreferidas de vizinhança no ELSA-Brasil. **Revista de Saúde Pública**, v. 47, supl. 2, p. 122-130, 2013.

SELLERA, P. E. G. et al. A ativação de redes sociotécnicas na Cidade Estrutural/DF: um território saudável e sustentável. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, n. 9, p. 3423-3434, 2019.

SINGER, E.; COUPER, M. P. Some methodological uses of responses to open questions and other verbatim comments in quantitative surveys. **methods, data, analyses**, v. 11, n. 2, p. 115-134, 2017.

SKIVINGTON, K. et al. A new framework for developing and evaluating complex interventions: update of Medical Research Council guidance. **BMJ**, v. 374, n2061, 2021.

SOLAR, O.; IRWIN, A. **A conceptual framework for action on the social determinants of health**. Geneva: World Health Organization, 2010. (Social Determinants of Health Discussion Paper 2: Policy and Practice).

STAR, S. L.; GRIESEMER, J. R. Institutional ecology, 'translations' and boundary objects: amateurs and professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. **Social Studies of Science**, v. 19, n. 3, p. 387-420, 1989.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez, 2011.

TONG, A.; SAINSBURY, P.; CRAIG, J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. **International Journal for Quality in Health Care**, v. 19, n. 6, p. 349-357, 2007.

TRAD, L. A. B.; ESPERIDIÃO, M. A. Gestão participativa e corresponsabilidade em saúde: limites e possibilidades no âmbito da Estratégia de Saúde da Família. **Interface**: Comunicação, Saúde, Educação, v. 13, n. 31, p. 557-570, 2009.

WILLIS, G. B. **Cognitive interviewing**: a tool for improving questionnaire design. Thousand Oaks: Sage, 2005.

YIN, R. K. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

YOUNG, S. L. et al. The Household Water InSecurity Experiences (HWISE) Scale: development and validation of a household water insecurity measure for low-income and middle-income countries. **BMJ Global Health**, v. 4, n. 5, e001750, 2019.

YOUNG, S. L. et al. Validity of a four-item Household Water Insecurity Experiences Scale for assessing water issues related to health and well-being. **American Journal of Tropical Medicine and Hygiene**, v. 104, n. 1, p. 391-394, 2021.

ZELEKE, A. A. et al. Data quality and cost-effectiveness analyses of electronic and paper-based interviewer-administered public health surveys: systematic review. **Journal of Medical Internet Research**, v. 23, n. 1, e21382, 2021.

APÊNDICE A – ROTEIRO-BASE DE ENTREVISTA COM PESQUISADORES POPULARES

O roteiro abaixo é a versão-base para o painel de pesquisadores populares. Roteiros específicos para os demais grupos seguem a mesma estrutura e serão testados na Fase 1. Em cada onda, o entrevistador retoma o que o participante relatou na onda anterior.

Onda 1 – ativação e cartografia

a) como você conheceu a PICAPS e o que o levou a participar;

b) quem mais participou das primeiras reuniões, e quem você esperava ver e não estava;

c) conte uma situação da cartografia social em que um problema do território foi discutido: o que foi dito, quem falou, o que foi decidido;

d) o que você espera que mude no território com esse processo.

Onda 2 – início da Sala de Cooperação Social

a) como foi a formação para você: o que fez sentido e o que não fez;

b) conte o último alerta ou demanda que você registrou: o que aconteceu depois;

c) como as decisões são tomadas nas reuniões da Sala, e quem tem mais influência;

d) como os profissionais da UBS têm recebido o que vocês levam.

Onda 3 – consolidação

a) o que mudou na sua atuação e na Sala desde a nossa última conversa;

b) conte um caso que avançou e um caso que não avançou: o que explica a diferença;

c) o que custa para você participar, em tempo, dinheiro, relações e riscos;

d) se a Sala deixasse de existir amanhã, o que se perderia, e o que continuaria.

APÊNDICE B – GUIA DE OBSERVAÇÃO DAS REUNIÕES DAS SALAS DE COOPERAÇÃO SOCIAL

O diário de campo de cada reunião registra, em seções separadas, a descrição dos fatos e a interpretação do pesquisador.

a) **contexto**: data, local, duração, número e perfil dos presentes (sem identificação nominal), presença de profissionais de APS e de vigilância;

b) **pauta e encaminhamentos**: temas tratados, origem de cada tema (alerta, Plano Popular, demanda externa), decisões tomadas e responsáveis;

c) **dinâmica deliberativa**: quem propõe, quem contesta, quem decide; temas encerrados sem deliberação; uso de dados, mapas ou do painel territorial;

d) **relação com os serviços**: retornos recebidos sobre encaminhamentos anteriores, ausência de retorno, reações do grupo;

e) **reflexividade**: impressões, desconfortos e possíveis efeitos da presença do pesquisador.

APÊNDICE C – FICHA DE RASTREAMENTO DE TRAJETÓRIA

Cada episódio rastreado (alerta da vigilância popular ou demanda do Plano Popular) é registrado nesta ficha, preenchida a partir de documentos e de entrevistas curtas com os atores envolvidos.

a) **identificação**: código do episódio, setor, tipo (alerta ou demanda), data do registro inicial;

b) **origem**: como o problema foi percebido, por quem e com que categorias foi descrito;

c) **percurso**: cada passagem entre atores (pesquisador popular, Sala, UBS, vigilância, gestão), com data, forma de comunicação e tradução realizada;

d) **desfecho**: resposta, recusa, reclassificação ou ausência de resposta, com data e justificativa apresentada;

e) **interpretação**: condições que explicam o desfecho, segundo cada ator e segundo a análise da equipe, e configuração contexto–mecanismo–resultado associada.

APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO MISTO SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE

Questionário para entrevista face a face, aplicado por entrevistador treinado a um morador de 18 anos ou mais, preferencialmente a pessoa responsável pelo domicílio ou seu cônjuge. Todas as perguntas admitem as respostas "não sabe" (código 98) e "não quis responder" (código 99), que não são lidas ao entrevistado. A coluna "Origem" indica o instrumento de referência. A indicação "adaptado" sinaliza alteração de redação em relação à fonte; os itens adaptados e os itens próprios passarão por entrevistas cognitivas antes do piloto. Esta é a versão 1.0, sujeita a ajustes após o teste cognitivo.

BLOCO A – CONTROLE (preenchido pelo entrevistador)

Nº	Pergunta	Opções de resposta	Origem
A1	Setor do território	1 Trecho 1; 2 Trecho 2; 3 Trecho 3; 4 Pôr do Sol	Próprio
A2	Código do setor censitário	Código IBGE (Censo 2022)	IBGE
A3	Número do domicílio na listagem	Número	Próprio
A4	Código do entrevistador	Código	Próprio
A5	Data e hora de início	dd/mm/aaaa; hh:mm	Próprio
A6	Resultado da visita	1 entrevista realizada; 2 recusa; 3 morador ausente após três visitas; 4 domicílio vago ou não residencial; 5 outro	Próprio
A7	O Termo de Consentimento foi lido, as dúvidas esclarecidas e o consentimento registrado?	1 sim; 2 não (encerrar)	Próprio

BLOCO B – MORADORES E RESPONDENTE

Nº	Pergunta	Opções de resposta	Origem
B1	Quantas pessoas moram neste domicílio, incluindo o(a) Sr(a)?	Número	PNS 2019
B2	Quantas delas têm menos de 18 anos?	Número (define a versão da EBIA)	PNS 2019
B3	Quantas têm 60 anos ou mais?	Número	PNS 2019
B4	Algum morador tem deficiência ou limitação permanente que dificulte as atividades do dia a dia?	1 sim; 2 não	Próprio
B5	Qual é a sua idade?	Anos completos	PNS 2019
B6	Qual é o seu sexo?	1 masculino; 2 feminino	PNS 2019
B7	Como o(a) Sr(a) se identifica quanto ao gênero?	1 mulher; 2 homem; 3 mulher trans ou travesti; 4 homem trans; 5 pessoa não binária; 6 outro	PDAD-A 2023 (adaptado)
B8	A sua cor ou raça é:	1 branca; 2 preta; 3 amarela; 4 parda; 5 indígena	IBGE

Nº	Pergunta	Opções de resposta	Origem
B9	Até que série ou ano o(a) Sr(a) estudou?	0 sem instrução; 1 fundamental incompleto; 2 fundamental completo; 3 médio incompleto; 4 médio completo; 5 superior incompleto; 6 superior completo	ABEP 2026
B10	O(a) Sr(a) é a pessoa responsável pelo domicílio?	1 sim (ir para B12); 2 não	Próprio
B11	Até que série ou ano estudou a pessoa responsável pelo domicílio?	Mesmas opções de B9	ABEP 2026
B12	Há quanto tempo o(a) Sr(a) mora no Sol Nascente/Pôr do Sol?	Anos (menos de 1 = 0)	Próprio
B13	Antes de morar aqui, onde o(a) Sr(a) morava?	1 sempre morou aqui; 2 outra Região Administrativa do DF (qual?); 3 outro estado (qual?)	Próprio

BLOCO C – TRABALHO, RENDA E PROTEÇÃO SOCIAL

Nº	Pergunta	Opções de resposta	Origem
C1	Na semana passada, o(a) Sr(a) trabalhou ou fez algum bico?	1 sim, com carteira assinada; 2 sim, sem carteira; 3 sim, por conta própria ou bico; 4 sim, servidor público; 5 não, mas procurou trabalho; 6 não e não procurou	PNS 2019 (adaptado)
C2	Nos últimos 12 meses, algum morador perdeu o trabalho ou teve redução importante da renda?	1 sim; 2 não	Próprio
C3	Somando tudo o que os moradores receberam no mês passado (salários, bicos, aposentadorias e benefícios), qual foi a renda total do domicílio?	Valor em R$; se não souber, faixa: 1 até 1 salário mínimo; 2 mais de 1 a 2; 3 mais de 2 a 3; 4 mais de 3 a 5; 5 mais de 5	PDAD-A 2023 (adaptado)
C4	Algum morador recebe o Bolsa Família?	1 sim; 2 não	Próprio
C5	Algum morador recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC)?	1 sim; 2 não	Próprio
C6	O domicílio está inscrito no Cadastro Único?	1 sim; 2 não; 98 não sabe	Próprio
C7	Nos últimos 12 meses, houve alguma vez em que não foi possível pagar o aluguel, a conta de água ou a conta de luz?	1 sim; 2 não	Próprio (domínio AHC)
C8	Nos últimos 12 meses, a água ou a luz deste domicílio foi cortada por falta de pagamento?	1 sim; 2 não	Próprio (domínio AHC)

BLOCO D – DOMICÍLIO, SANEAMENTO E ENTORNO

Nº	Pergunta	Opções de resposta	Origem
D1	Este domicílio é:	1 próprio, já pago; 2 próprio, ainda pagando; 3 alugado; 4 cedido; 5 ocupação; 6 outro	PNS 2019; PDAD-A 2023
D2	Qual é o material que predomina nas paredes externas?	1 alvenaria com revestimento; 2 alvenaria sem revestimento; 3 madeira apropriada para construção; 4 madeira aproveitada ou taipa; 5 outro	PNS 2019
D3	Quantos cômodos são usados para dormir?	Número	PNS 2019

Nº	Pergunta	Opções de resposta	Origem
D4	Quantos banheiros de uso exclusivo dos moradores, com chuveiro e vaso sanitário, existem no domicílio?	0; 1; 2; 3; 4 ou mais	ABEP 2026
D5	O domicílio é atendido por rede geral de distribuição de água?	1 sim; 2 não	ABEP 2026
D6	Com que frequência a água da rede geral chega a este domicílio?	1 diariamente; 2 de 4 a 6 dias por semana; 3 de 1 a 3 dias por semana; 4 outra; 5 não se aplica	PNS 2019 (adaptado)
D7	Para onde vai o esgoto do banheiro?	1 rede geral; 2 fossa séptica ligada à rede; 3 fossa séptica não ligada à rede; 4 fossa rudimentar; 5 vala ou céu aberto; 6 outro	PNS 2019
D8	O que é feito com o lixo deste domicílio?	1 coletado diretamente; 2 colocado em caçamba; 3 queimado ou enterrado; 4 jogado em terreno baldio ou na rua; 5 outro	PNS 2019
D9	Próximo ao domicílio existem ruas que alagam?	1 sim; 2 não	PDAD-A 2023
D10	Próximo ao domicílio existe esgoto a céu aberto?	1 sim; 2 não	PDAD-A 2023
D11	A rua principal de acesso a este domicílio tem iluminação?	1 sim; 2 não	PDAD-A 2023
D12	Nas proximidades do domicílio existe policiamento regular?	1 sim; 2 não	PDAD-A 2023
D13	Nos últimos 12 meses, este domicílio foi atingido por alagamento, enxurrada ou erosão?	1 sim; 2 não	Próprio
D14	Nos últimos 12 meses, o calor dentro de casa prejudicou o sono ou a saúde de algum morador?	1 nunca; 2 às vezes; 3 frequentemente	Próprio
D15	Quantos destes itens existem no domicílio: a) automóvel de passeio; b) geladeira; c) microcomputador (computador de mesa, notebook ou similar); d) máquina de lavar louça; e) máquina de lavar roupa (exceto tanquinho); f) forno de micro-ondas?	Para cada item: 0; 1; 2; 3; 4 ou mais	ABEP 2026
D16	Há trabalhador(a) doméstico(a) mensalista no domicílio, que trabalhe cinco dias ou mais por semana?	1 sim; 2 não	ABEP 2026

BLOCO E – ÁGUA (tradução preliminar da HWISE-4, a adaptar)

Nº	Pergunta	Opções de resposta	Origem
E1	Nas últimas 4 semanas, com que frequência o(a) Sr(a) ou alguém do domicílio se preocupou por não ter água suficiente para todas as necessidades da casa?	0 nunca; 1 raramente (1 a 2 vezes); 2 às vezes (3 a 10 vezes); 3 frequentemente (11 a 20 vezes); 3 sempre (mais de 20 vezes)	HWISE-4
E2	Nas últimas 4 semanas, com que frequência vocês tiveram de mudar planos ou atividades por problemas com a água?	0 nunca; 1 raramente (1 a 2 vezes); 2 às vezes (3 a 10 vezes); 3 frequentemente (11 a 20 vezes); 3 sempre (mais de 20 vezes)	HWISE-4
E3	Nas últimas 4 semanas, com que frequência não houve água suficiente para beber, como gostariam?	0 nunca; 1 raramente (1 a 2 vezes); 2 às vezes (3 a 10 vezes); 3 frequentemente (11 a 20 vezes); 3 sempre (mais de 20 vezes)	HWISE-4

Nº	Pergunta	Opções de resposta	Origem
E4	Nas últimas 4 semanas, com que frequência não houve água suficiente para lavar as mãos depois de atividades sujas, como usar o banheiro ou trocar fraldas?	0 nunca; 1 raramente (1 a 2 vezes); 2 às vezes (3 a 10 vezes); 3 frequentemente (11 a 20 vezes); 3 sempre (mais de 20 vezes)	HWISE-4

Pontuação da HWISE-4: soma de 0 a 12; escore igual ou superior a 4 indica insegurança hídrica (YOUNG et al., 2021).

BLOCO F – SEGURANÇA ALIMENTAR

Nº	Pergunta	Opções de resposta	Origem
F1 a F14	Aplicar a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) conforme o Anexo A. Os itens F9 a F14 só se aplicam a domicílios com moradores de menos de 18 anos (B2 maior que 0).	1 sim; 2 não (em cada item)	EBIA (IBGE, 2025)
F15	Nos últimos 12 meses, o domicílio recebeu cesta básica ou doação de alimentos?	1 sim; 2 não	Próprio

Para o bloco G, o entrevistador explica: "Vou ler algumas frases sobre a sua vizinhança, isto é, a área que dá para percorrer a pé em cerca de 10 minutos a partir da sua casa. Diga o quanto concorda com cada uma." Os itens G1 a G5 deverão ter a redação harmonizada com a versão validada no ELSA-Brasil (SANTOS, S. M. et al., 2013) antes do teste cognitivo.

BLOCO G – VIZINHANÇA, SEGURANÇA E COESÃO

Nº	Pergunta	Opções de resposta	Origem
G1	As pessoas desta vizinhança estão dispostas a ajudar seus vizinhos.	1 concorda totalmente; 2 concorda; 3 nem concorda nem discorda; 4 discorda; 5 discorda totalmente	ELSA-Brasil (adaptado)
G2	Esta é uma vizinhança unida.	1 concorda totalmente; 2 concorda; 3 nem concorda nem discorda; 4 discorda; 5 discorda totalmente	ELSA-Brasil (adaptado)
G3	Pode-se confiar nas pessoas desta vizinhança.	1 concorda totalmente; 2 concorda; 3 nem concorda nem discorda; 4 discorda; 5 discorda totalmente	ELSA-Brasil (adaptado)
G4	As pessoas desta vizinhança geralmente não se dão bem umas com as outras.	1 concorda totalmente; 2 concorda; 3 nem concorda nem discorda; 4 discorda; 5 discorda totalmente (pontuação invertida)	ELSA-Brasil (adaptado)
G5	As pessoas desta vizinhança não têm os mesmos valores.	1 concorda totalmente; 2 concorda; 3 nem concorda nem discorda; 4 discorda; 5 discorda totalmente (pontuação invertida)	ELSA-Brasil (adaptado)
G6	O(a) Sr(a) se sente seguro(a) andando na sua vizinhança durante o dia?	1 sim; 2 não	Próprio
G7	E à noite?	1 sim; 2 não	Próprio
G8	Nos últimos 6 meses, com que frequência houve brigas com armas, tiroteios ou outras formas de violência na sua vizinhança?	1 nunca; 2 raramente; 3 às vezes; 4 frequentemente	ELSA-Brasil (adaptado)
G9	Nos últimos 12 meses, algum morador deste domicílio foi vítima de assalto, furto, agressão ou outra violência na vizinhança?	1 sim; 2 não	ELSA-Brasil (adaptado)

BLOCO H – APOIO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO

Nº	Pergunta	Opções de resposta	Origem
H1	Com quantos familiares ou parentes o(a) Sr(a) pode contar em momentos bons ou ruins?	Número	PNS 2019 (módulo M)
H2	Com quantos amigos próximos o(a) Sr(a) pode contar em momentos bons ou ruins?	Número	PNS 2019 (módulo M)
H3	Nos últimos 12 meses, com que frequência o(a) Sr(a) participou de: a) associação de moradores ou movimento social; b) atividades religiosas coletivas; c) conselho de saúde ou outro conselho; d) trabalho voluntário?	Para cada item: 1 nunca; 2 uma vez no ano ou menos; 3 algumas vezes no ano; 4 uma vez por mês ou mais	PNS 2019 (módulo M, adaptado)
H4	O(a) Sr(a) conhece ou já ouviu falar: a) da PICAPS; b) da Sala de Cooperação Social do seu setor; c) dos pesquisadores populares?	Para cada item: 1 conhece; 2 já ouviu falar; 3 não conhece	Próprio
H5	O(a) Sr(a) ou alguém deste domicílio já participou de alguma atividade da PICAPS, como reunião, cartografia ou oficina?	1 sim; 2 não; 98 não sabe	Próprio

BLOCO I – DISCRIMINAÇÃO

Nº	Pergunta	Opções de resposta	Origem
I1	Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a) foi tratado(a) de forma injusta ou discriminado(a): a) em serviços de saúde; b) ao procurar emprego ou no trabalho; c) por policiais; d) em lojas, bancos ou comércio; e) em escolas ou outros órgãos públicos; f) por vizinhos ou na comunidade?	Para cada situação: 1 sim; 2 não	EDE (adaptado)
I2	Se houve alguma dessas situações: por qual motivo o(a) Sr(a) acha que foi tratado(a) assim? (aceita mais de uma resposta)	1 cor ou raça; 2 lugar onde mora; 3 renda ou classe social; 4 sexo; 5 orientação sexual ou identidade de gênero; 6 idade; 7 religião; 8 aparência ou modo de vestir; 9 deficiência; 10 outro	EDE (adaptado)

BLOCO J – SAÚDE E ACESSO AOS SERVIÇOS

Nº	Pergunta	Opções de resposta	Origem
J1	Em geral, como o(a) Sr(a) avalia a sua saúde?	1 muito boa; 2 boa; 3 regular; 4 ruim; 5 muito ruim	PNS 2019 (N1)
J2	Algum médico já lhe deu o diagnóstico de hipertensão arterial (pressão alta)?	1 sim; 2 não	PNS 2019 (Q2a)
J3	Algum médico já lhe deu o diagnóstico de diabetes?	1 sim; 2 não	PNS 2019 (Q30a)
J4	Algum médico ou profissional de saúde mental já lhe deu o diagnóstico de depressão?	1 sim; 2 não	PNS 2019 (adaptado)
J5	O seu domicílio está cadastrado na unidade de Saúde da Família?	1 sim; 2 não; 3 não sabe	PNS 2019 (B1)

Nº	Pergunta	Opções de resposta	Origem
J6	Nos últimos doze meses, com que frequência o seu domicílio recebeu uma visita de algum Agente Comunitário ou algum membro da Equipe de Saúde da Família?	1 mensalmente; 2 a cada 2 meses; 3 de 2 a 4 vezes; 4 uma vez; 5 nunca recebeu	PNS 2019 (B3)
J7	Quando o(a) Sr(a) precisa de atendimento de saúde, onde costuma procurar primeiro?	1 Unidade Básica de Saúde; 2 UPA ou pronto-socorro; 3 hospital público; 4 farmácia; 5 serviço particular ou plano de saúde; 6 outro	PNS 2019 (adaptado)
J8	Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a) ou alguém deste domicílio precisou de atendimento de saúde e não conseguiu?	1 sim; 2 não	Próprio
J9	Se sim: por quê? (aceita mais de uma resposta)	1 não havia vaga ou ficha; 2 demora; 3 distância ou falta de transporte; 4 horário incompatível com o trabalho; 5 não sabia onde procurar; 6 custo; 7 outro	Próprio
J10	Nos últimos 12 meses, a falta de transporte ou de dinheiro para a passagem impediu o(a) Sr(a) de ir a consultas, ao trabalho ou a outros serviços?	1 sim; 2 não	Próprio (domínio AHC)

BLOCO K – ACESSO DIGITAL

Nº	Pergunta	Opções de resposta	Origem
K1	Algum morador tem telefone celular com acesso à internet?	1 sim; 2 não	Próprio
K2	O domicílio tem acesso à internet, por rede, wi-fi ou dados móveis?	1 sim; 2 não	PNS 2019 (adaptado)

Para o bloco L, o entrevistador lê cada pergunta sem sugerir respostas, registra a fala literalmente, usando as palavras do entrevistado, e pode estimular com "Pode me contar mais?".

BLOCO L – QUESTÕES ABERTAS

Nº	Pergunta	Finalidade	Questão de pesquisa
L1	Na sua opinião, quais são os principais problemas que afetam a saúde das pessoas que moram nesta rua ou quadra?	Profundidade; comparação com a cartografia social	Q1, Q3
L2	O que precisaria mudar neste bairro para que as pessoas vivessem com mais saúde?	Profundidade	Q1, Q3
L3	Conte uma situação recente em que o(a) Sr(a) ou alguém desta casa precisou de um serviço de saúde ou de outro serviço público. Como foi?	Profundidade sobre a experiência com os serviços	Q4
L4	Quando surge um problema no bairro, como lixo, esgoto, violência ou uma doença que se espalha, a quem as pessoas recorrem? O que costuma acontecer?	Profundidade sobre os caminhos de resolução	Q3, Q4
L5	Se o(a) Sr(a) pudesse levar um problema do bairro para a unidade de saúde ou para o governo, qual seria? Por quê?	Comparação com o Plano Popular	Q3

Nº	Pergunta	Finalidade	Questão de pesquisa
L6	Há algo mais sobre a vida e a saúde neste bairro que não perguntamos e que o(a) Sr(a) gostaria de dizer?	Rede de segurança	Todas

BLOCO M – ENCERRAMENTO

Nº	Pergunta	Opções de resposta	Origem
M1	Podemos entrar em contato novamente para convidá-lo(a) para uma conversa mais longa sobre a vida e a saúde no bairro? A participação é voluntária.	1 sim (registrar o contato em formulário separado); 2 não	Próprio
M2	Entrega do folheto com os serviços de saúde, assistência social e proteção do território (realizada em todos os domicílios)	1 entregue	Próprio
M3	Hora de término	hh:mm	Próprio
M4	Observações do entrevistador: presença de outras pessoas, interrupções, dificuldades de compreensão	Texto	Próprio

ANEXO A – ESCALA BRASILEIRA DE INSEGURANÇA ALIMENTAR (EBIA)

Itens reproduzidos do manual de segurança alimentar da PNAD Contínua (IBGE, 2025), com resposta sim ou não e período de referência dos últimos três meses. Os itens 9 a 14 aplicam-se apenas a domicílios com moradores de menos de 18 anos. A classificação soma as respostas afirmativas, segundo os pontos de corte adotados pelo IBGE (IBGE, 2020).

Item	Pergunta
F1	Nos últimos três meses, os moradores deste domicílio tiveram a preocupação de que os alimentos acabassem antes de poderem comprar ou receber mais comida?
F2	Nos últimos três meses, os alimentos acabaram antes que os moradores deste domicílio tivessem dinheiro para comprar mais comida?
F3	Nos últimos três meses, os moradores deste domicílio ficaram sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada?
F4	Nos últimos três meses, os moradores deste domicílio comeram apenas alguns poucos tipos de alimentos que ainda tinham por que o dinheiro acabou?
F5	Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, deixou de fazer alguma refeição porque não havia dinheiro para comprar a comida?
F6	Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, alguma vez comeu menos do que achou que devia porque não havia dinheiro para comprar comida?
F7	Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, alguma vez sentiu fome, mas não comeu porque não havia dinheiro para comprar comida?
F8	Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, alguma vez, fez apenas uma refeição ao dia ou ficou um dia inteiro sem comer porque não havia dinheiro para comprar comida?
F9	Nos últimos três meses, algum morador com menos de 18 anos de idade, alguma vez, deixou de ter uma alimentação saudável e variada porque não havia dinheiro para comprar comida?
F10	Nos últimos três meses, algum morador com menos de 18 anos de idade, alguma vez, comeu menos do que deveria porque não havia dinheiro para comprar a comida?
F11	Nos últimos três meses, alguma vez, foi diminuída a quantidade de alimentos das refeições de algum morador com menos de 18 anos de idade, porque não havia dinheiro para comprar comida?
F12	Nos últimos três meses, alguma vez, algum morador com menos de 18 anos de idade, deixou de fazer alguma refeição, porque não havia dinheiro para comprar comida?
F13	Nos últimos três meses, alguma vez, algum morador com menos de 18 anos de idade, sentiu fome, mas não comeu porque não havia dinheiro para comprar comida?
F14	Nos últimos três meses, alguma vez, algum morador com menos de 18 anos de idade, fez apenas uma refeição ao dia ou ficou sem comer por um dia inteiro porque não havia dinheiro para comprar comida?

Classificação	Domicílios com moradores de menos de 18 anos (0 a 14)	Domicílios sem moradores de menos de 18 anos (0 a 8)
Segurança alimentar	0	0
Insegurança alimentar leve	1 a 5	1 a 3
Insegurança alimentar moderada	6 a 9	4 a 5

Classificação	Domicílios com moradores de menos de 18 anos (0 a 14)	Domicílios sem moradores de menos de 18 anos (0 a 8)
Insegurança alimentar grave	10 a 14	6 a 8

Fonte: IBGE (2020; 2025).

ANEXO B – CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL 2026

Sistema de pontos do Critério de Classificação Econômica Brasil, versão vigente desde fevereiro de 2026 (ABEP, 2026), aplicado a partir dos itens B9 ou B11, D4, D5, D15 e D16 do questionário. A pontuação deve ser conferida com o documento oficial da ABEP antes do uso.

Item	0	1	2	3	4 ou mais
Automóveis	0	4	8	10	11
Geladeiras	0	6	10	12	13
Microcomputadores	0	6	11	13	15
Banheiros	0	9	15	19	20

Item de posse	Pontos se possui
Máquina de lavar louça	5
Máquina de lavar roupa (exceto tanquinho)	6
Forno de micro-ondas	7
Trabalhador(a) doméstico(a) mensalista	5
Domicílio atendido por rede geral de distribuição de água	10

Escolaridade da pessoa responsável	Pontos
Sem instrução	0
Fundamental incompleto	3
Fundamental completo	4
Médio incompleto	5
Médio completo	6
Superior incompleto	6
Superior completo	8

Classe	Pontos
A	73 a 100
B1	66 a 72
B2	55 a 65
C1	46 a 54
C2	35 a 45
DE	0 a 34

Fonte: ABEP (2026).